

ANGINES ET PHARYNGITES AIGUES ET CHRONIQUES



Clinica **ORL**
TIMISOARA

PLAN

I. Généralités

II. Rhinopharyngites

III. Angines

IV. Complications des angines

I. Généralités

1. TERMINOLOGIE

**2. ANNEAU DE WALDEYER ET
MATURATION IMMUNITAIRE**

3. RAPPELS ANATOMIQUES

1. Terminologie

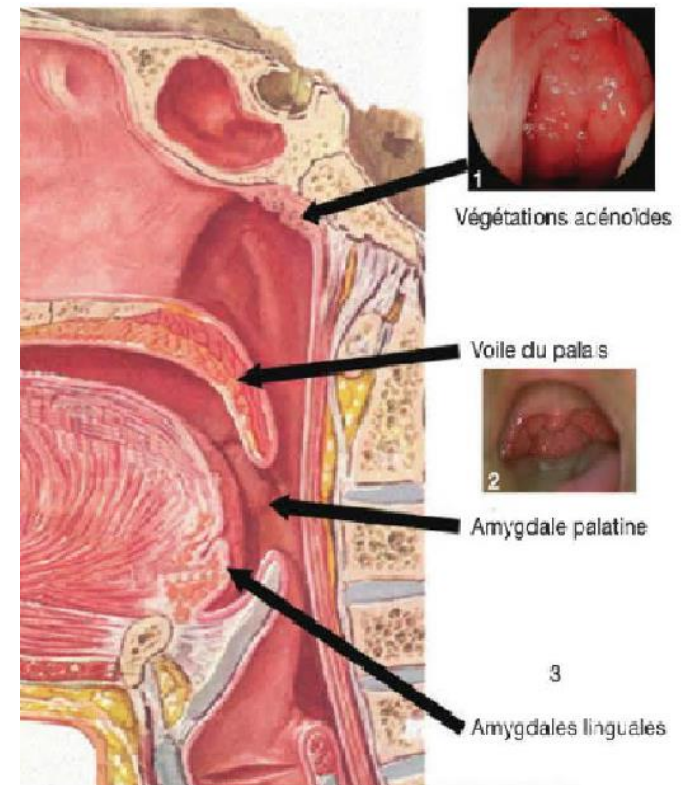
Angine: désigne une inflammation (d'origine infectieuse) des amygdales palatines.

Pharyngite: désigne une inflammation diffuse de l'oropharynx.

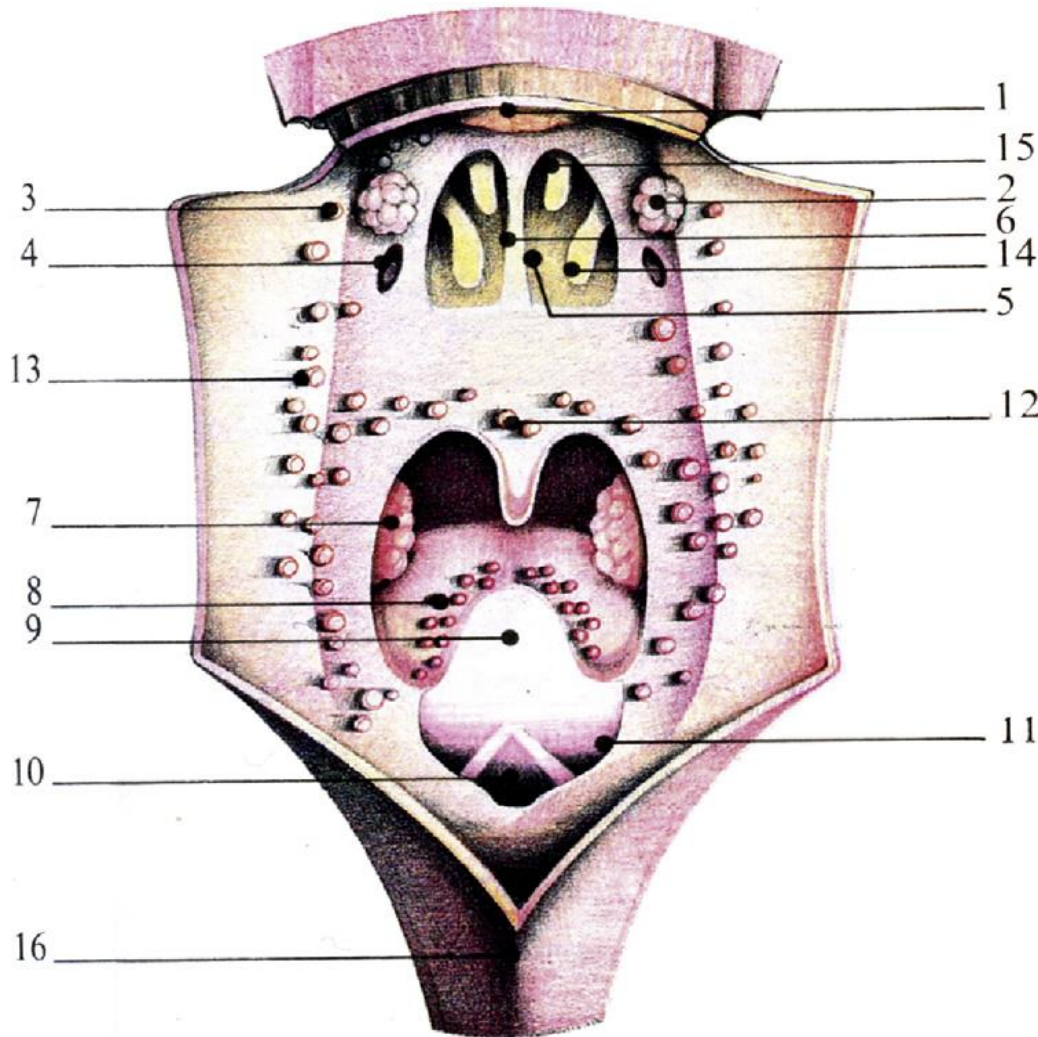
Toute angine est accompagnée d'une pharyngite!

2. Anneau de Waldeyer

- Cercle oro-pharyngé de tissu lymphoïde qui constitue une partie importante du tissu lymphatique périphérique.
- Il est composé par:
 - *Les amygdales palatines*
 - *Les amygdales pharyngées*
 - *L'amygdale linguale*



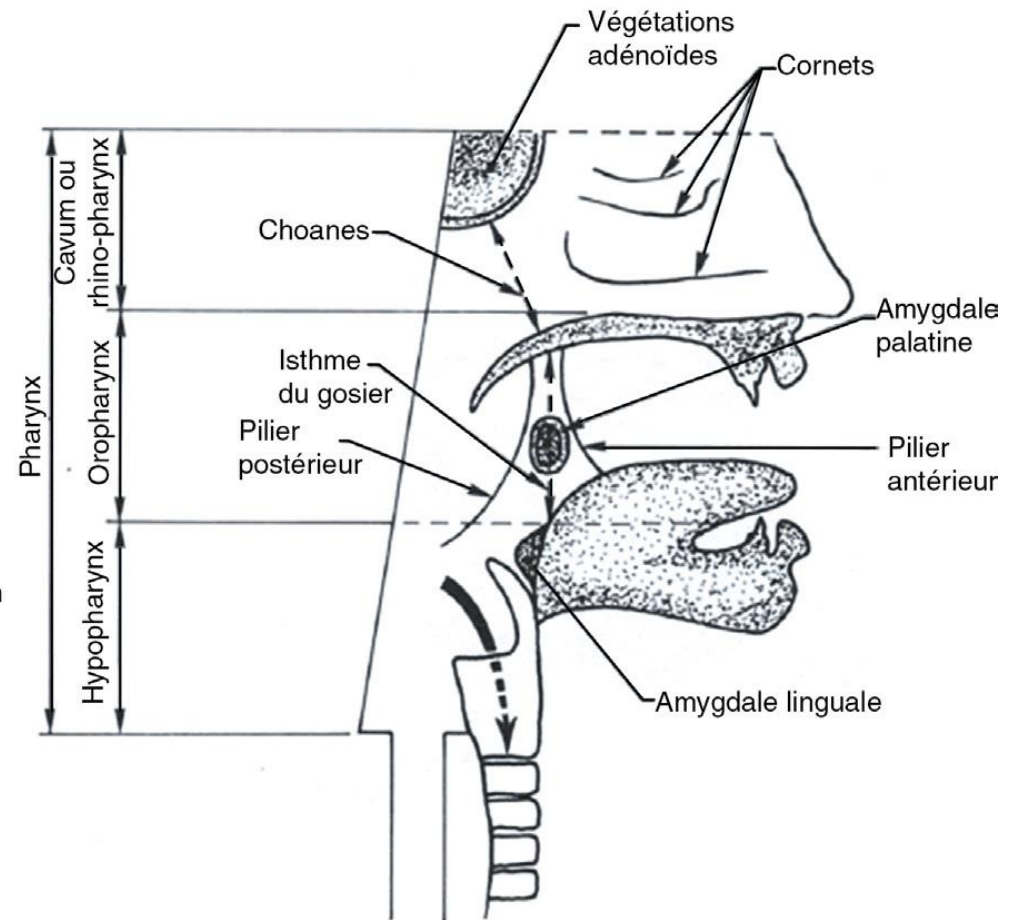
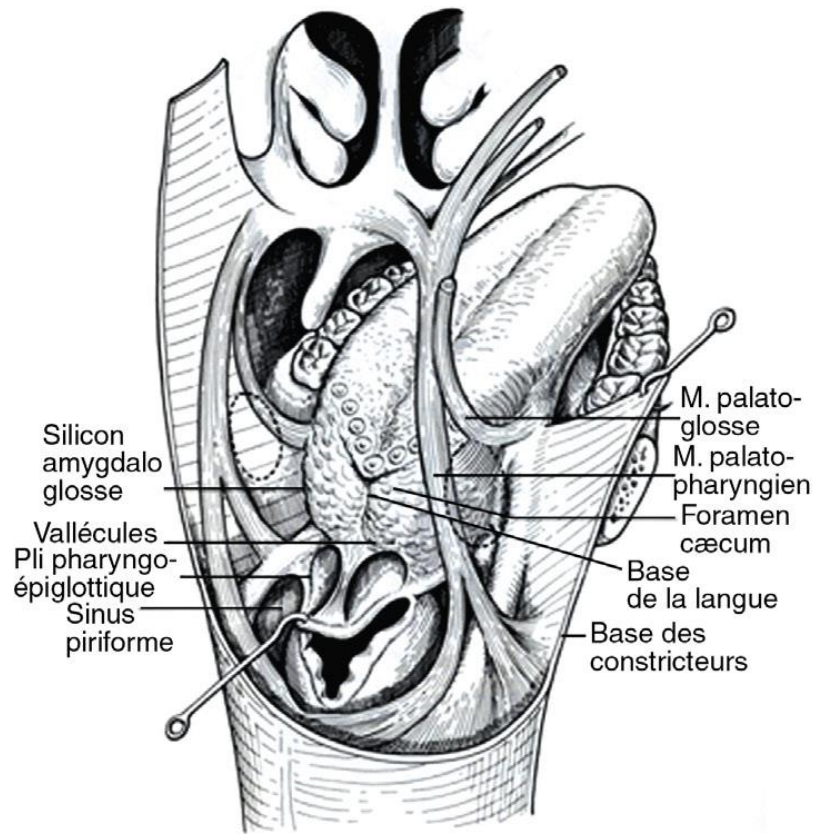
2. Anneau de Waldeyer



- 1 : amygdale pharyngée
- 2 : amygdale tubaire
- 3 : fossette de Rosenmüller
- 4 : orifice de la trompe d'Eustache
- 5 : choane droite
- 6 : cloison nasale
- 7 : amygdale palatine
- 8 : amygdale linguale
- 9 : épiglotte
- 10 : larynx
- 11 : paroi du pharynx
- 12 : voile du palais et luette
- 13 : follicules lymphoïdes formant une traînée qui relie entre elles les diverses amygdales
- 14 : cornet inférieur
- 15 : cornet moyen
- 16 : oesophage.

Anneau lymphatique de Waldeyer.

3. Rappels anatomiques

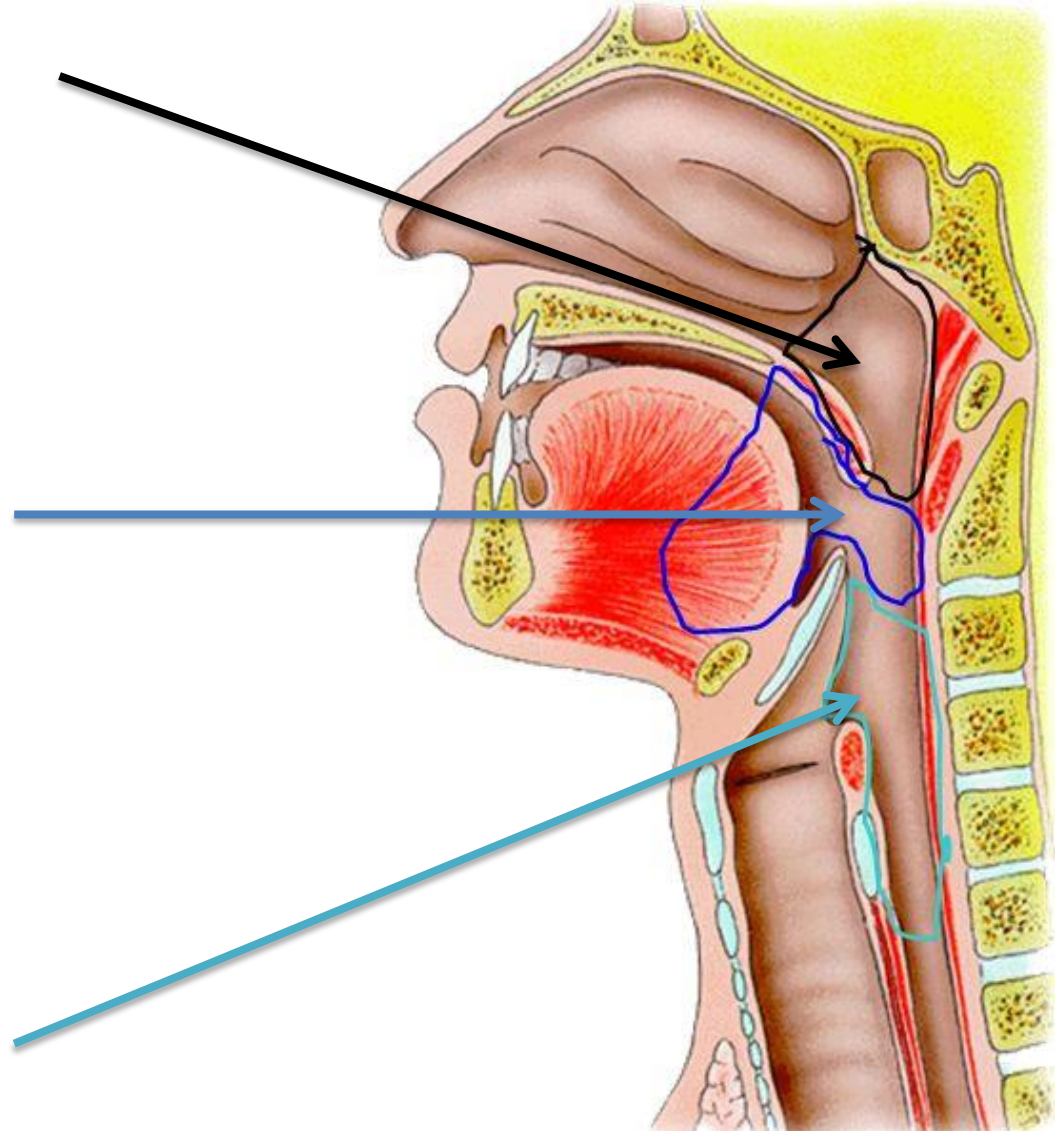


3. Rappels anatomiques

Rhinopharynx

Oropharynx

Hypopharynx

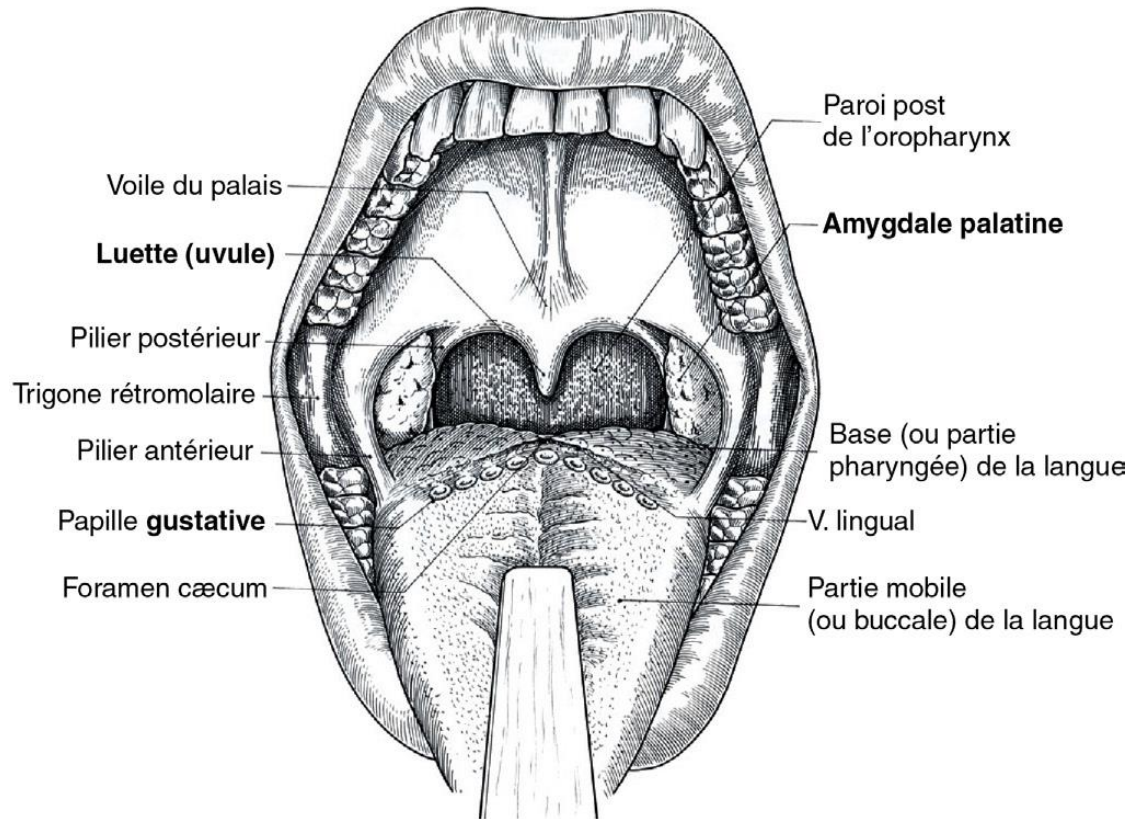


Amygdales palatines

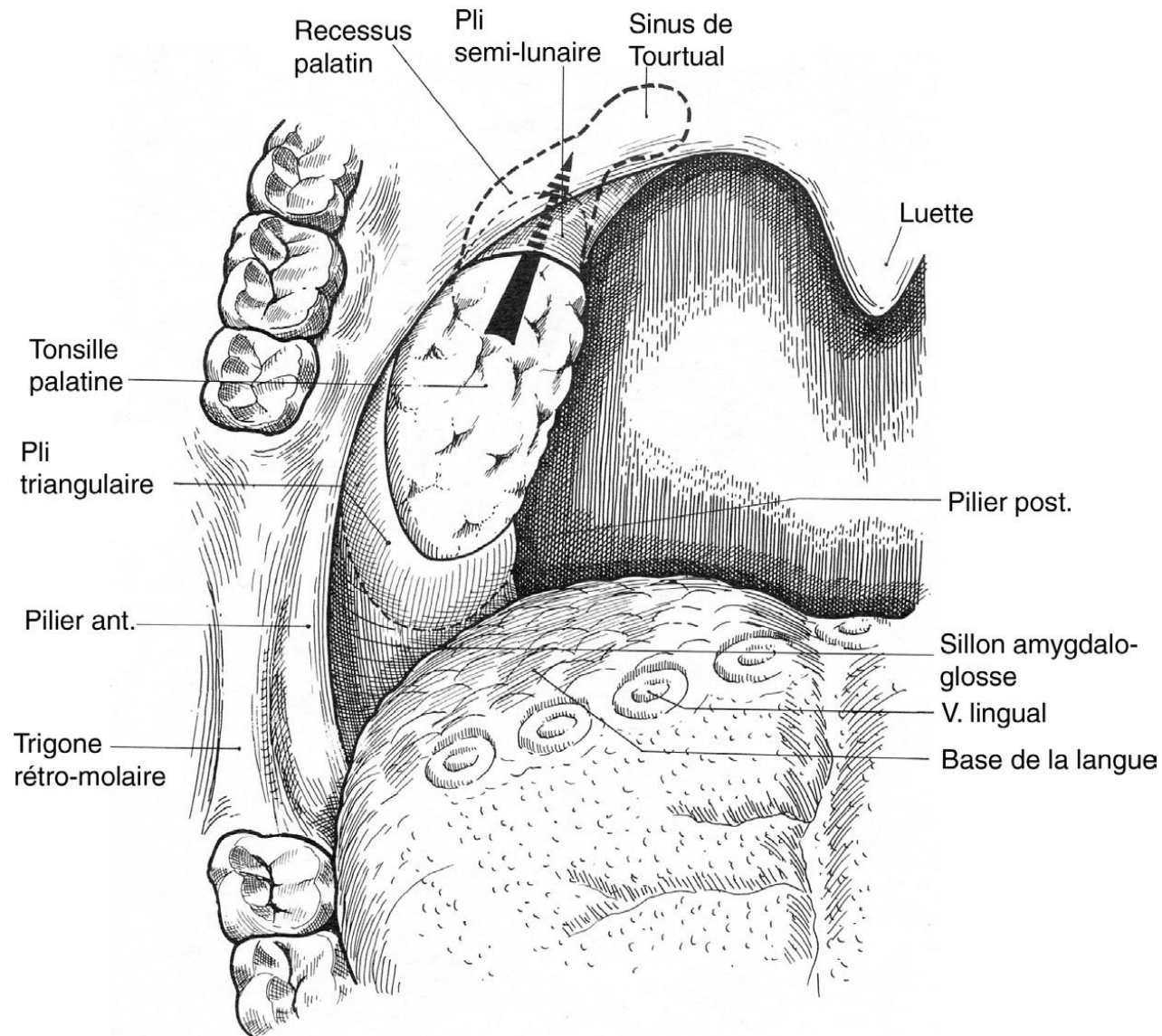
- formations lymphoïdes paires et symétriques
- visibles à l'examen de l'isthme du gosier
- Contenues dans la loge amygdalienne située entre les piliers antérieur et postérieur du voile.

Amygdales palatines

« buccopharyngoscopie »



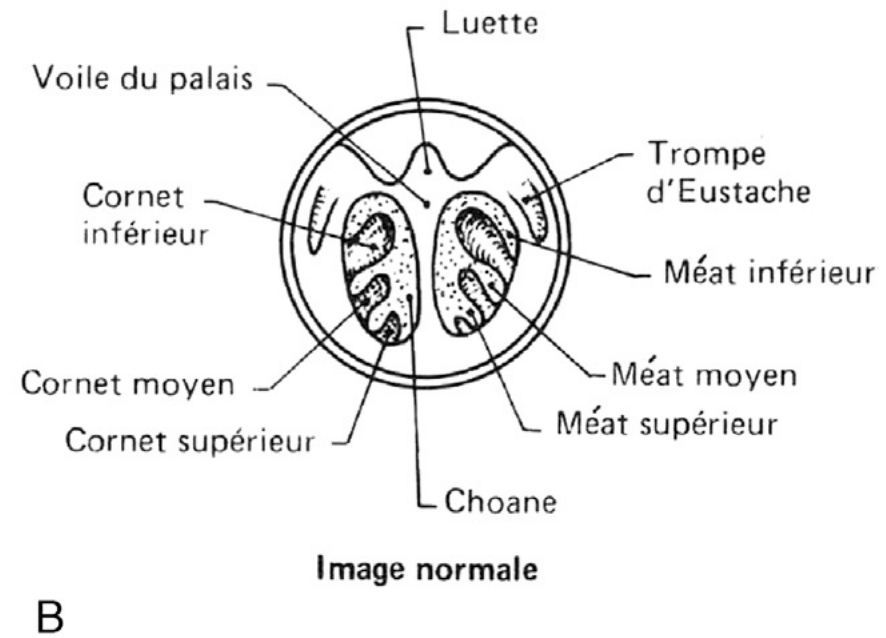
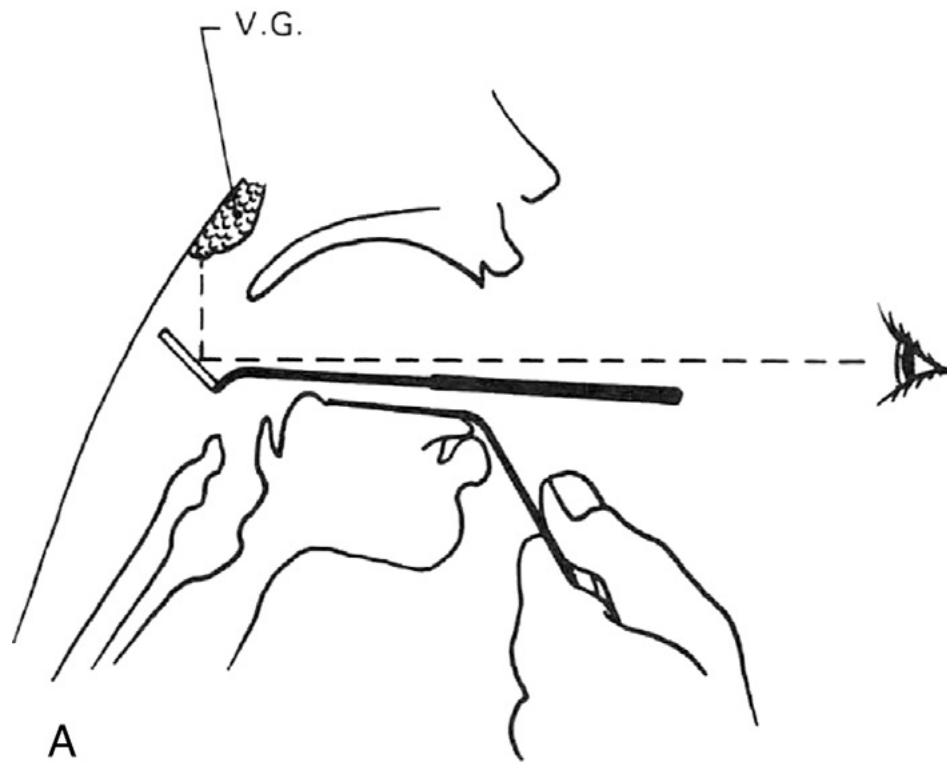
Amygdales palatines



Amygdales pharyngées (Adénoïdes)

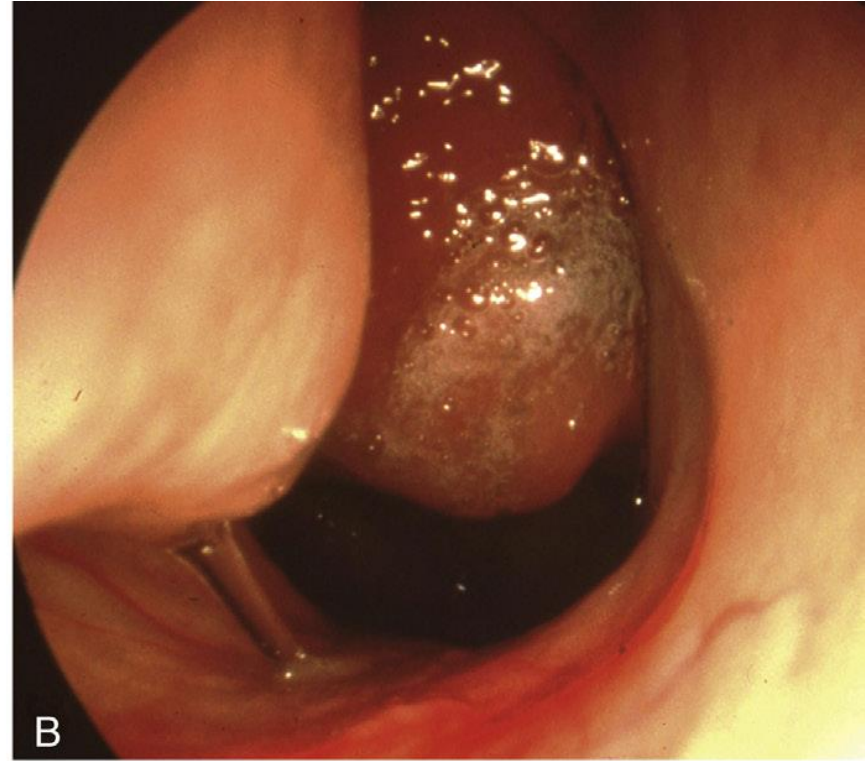
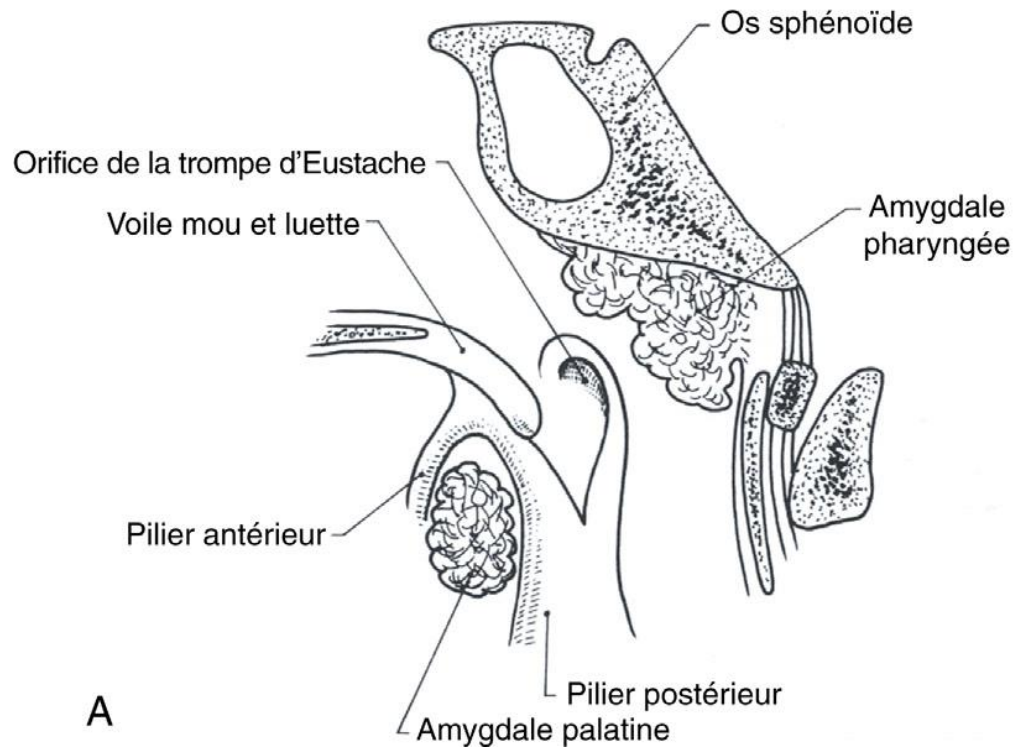
- Elles se développent dans une cavité aux parois osseuses inextensibles dans laquelle débouchent les deux trompes d'Eustache.

Amygdales pharyngées (Adénoïdes)



Rhinoscopie postérieure au miroir

Amygdales pharyngées (Adénoïdes)



- A. Coupe sagittale du cavum ou rhinopharynx.
- B. Végétations adénoïdes vues à l'optique passée par la fosse nasale droite.

II. Rhinopharyngite

1. DÉFINITION

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES

3. EXAMEN CLINIQUE

4. TRAITEMENT

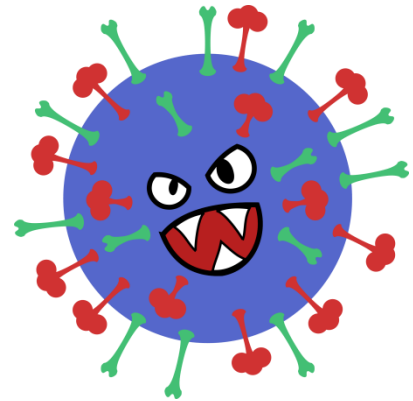
1. Définition

Rhinopharyngite :

Atteinte inflammatoire de l'étage supérieur du pharynx (rhinopharynx), associée à une atteinte nasale.

Maladie infectieuse très fréquente chez le petit enfant.

2. Étiologie



- Infection d'origine virale.
- Virus:
 - Rhinovirus,
 - Coronavirus,
 - Virus respiratoire syncytial (VRS),
 - Virus influenzae et Parainfluenzae,
 - Adénovirus,
 - Entérovirus

2. Manifestations cliniques

- Infections virales évoluant en 2 phases
- 1ère phase *catarrhale* :
 - Pharyngite puis une rhinite aqueuse abondante
 - Éternuements
 - Toux
 - Obstruction nasale
 - Fièvre modérée
- 2ème phase:
 - Destruction du tapis ciliaire par l'infection virale rhinorrhée antérieure et/ou postérieure (jetage postérieur).
 - Mouchage épais coloré faisant penser (à tort) à une surinfection bactérienne.

3. Examen clinique

- Retrouve:
 - Une inflammation diffuse de la muqueuse pharyngée et nasale
 - Sécrétions claires ou mucopurulentes diffuses dans les fosses nasales avec des ostiums nasaux libres
 - Adénopathies cervicales, diffuses bilatérales, sensibles et souvent de petite taille

4. Traitement

- La rhinopharyngite est une affection bénigne spontanément résolutive
- Traitement symptomatique associant antalgiques, antipyrétiques et lavage nasal.
- **PAS d'AINS**
- **PAS de Corticoïdes**



III. ANGINES

- 1. ÉPIDÉMIOLOGIE**
- 2. FORMES CLINIQUES**
- 3. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL**
- 4. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES**
- 5. TRAITEMENT**

1. épidémiologie

- La majorité des angines aiguës est d'origine virale.
- Les virus responsables: Adénovirus, virus influenzae, virus parainfluenzae, virus respiratoire syncytial, etc
- La principale bactérie est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A;
- La gravité des angines bactériennes à SBGA est liée au risque de complications locorégionales et générales
- Les autres angines bactériennes sont exceptionnelles et leur tableau clinique très différent.

2. Tableau clinique

- L'angine constitue un syndrome associant:
 - Fièvre
 - Odynophagie
 - Inflammation de l'oropharynx

2. Formes cliniques

La classification des angines est anatomoclinique:

- *Angines érythémateuses et érythémato-pultacées* (80 à 90 % des cas).
- *Angines pseudo-membraneuses.*
- *Angines vésiculeuses*, toujours d'origine virale.
- *Angines ulcéreuses* unilatérales.

Angines érythémateuses

- Angine rouge.
- Origine virale, le plus souvent!
- Signes associés rhinorrhée, toux, arthralgies, diarrhée
 - ☐ Influenza virus
 - ☐ Parainfluenza virus
 - ☐ Rhinovirus
 - ☐ Adenoviruses
 - ☐ VRS
 - ☐ Coronaviruses

Angines érythémateuses



- Aspect rouge vif du pharynx, des amygdales et des bords de la langue.

Angines érythémateuses

Les formes cliniques:

- **l'angine de la grippe** où prédominent les signes généraux, tandis que les signes pharyngés sont au second plan.
- **la fièvre pharyngo-conjonctivale** à Adénovirus (virus APC),

triade associant

- ☐ Pharyngite
- ☐ conjonctivite
- ☐ adénopathies cervicales sous-angulo-maxillaires;

Traitement

Le traitement est uniquement symptomatique pour une infection virale d'un sujet immunocompétent

- Antalgique
- Antipyrétique
- Le traitement du rhinite associée

Angines érythématopultacées

- Angine blanche
- Succède l'angine rouge
- Présence sur des amygdales rouges d'un exsudat pultacé: gris jaunâtre, punctiforme ou en trainées, mince et friable
- Facilement dissociable ne débordant pas de la surface amygdalienne.
- Étiologie: SBHA, autres streptocoque spp, staphylocoques, pasteurella tularensis (Tularémie) Toxoplasma gondii (Toxoplasmose)

Étiologie

- SBHA
- Autres streptocoque spp
- Staphylocoques
- Pasteurella tularensis (Tularémie)
- Toxoplasma gondii (Toxoplasmose)

Angines érythématopultacées



Traitement

- Ne traiter que les angines à SGA sélectionnées par l'utilisation d'outils diagnostiques (TDR)
- Score de Mac Isaac chez l'adulte

Fièvre		1
Absence de toux		1
Aénopathie latérocervicales sensibles		1
Atteinte amygdalienne (hypertrophie , exsudat)		1
Age	15 à 44 ans	= 0
	> 45 ans	= -1

Traitement antibiotique des angines à SGA

- **Prévenir les complications poststreptococciques non suppuratives, notamment le RAA.**
- Réduire le risque de suppuration locorégionale

Antibiotiques	Posologies (quotidiennes établies pour adulte/ enfant à fonction rénale normale)	Durée de traitement
β-lactamines		
Pénicilline : amoxicilline	Adulte : 2 g/j en deux prises Enfant 30 mois : 50 mg/kg/j en deux prises (sans dépasser la posologie adulte)	6 jours
C2G : Céfuroxime-axétil	Adulte : 500 mg/j en deux prises	4 jours
C3G : Céfotiam	Adulte : 400 mg/j en deux prises	5 jours
Cefpodoxime	Adulte : 200 mg/j en deux prises Enfant : 8 mg/kg/j en deux prises (sans dépasser la posologie adulte)	5 jours
Macrolides ^a		
Azithromycine	Adulte : 500 mg/j en une prise unique journalière Enfant : 20 mg/kg/j, en une prise, sans dépasser la posologie adulte	3 jours
Clarithromycine (standard)	Adulte : 500 mg/j en deux prises Enfant : 15 mg/kg/j en deux prises sans dépasser la posologie adulte	5 jours
Clarithromycine (LP)	Adulte : 500 mg/j en une prise journalière	5 jours
Josamycine	Adulte : 2 g/j en deux prises Enfant : 50 mg/kg/j en deux prises (sans dépasser la posologie adulte)	5 jours

Angines pseudomembraneuses

- Fausses membranes nacrées, extensives, pouvant déborder la région amygdalienne, le voile et ses piliers.
- Étiologie:
 - *Epstein-Barr virus*: mononucléose infectieuse MNI
 - *Corynebacterium diphtheriae* : diphtérie

Mononucléose infectieuse

- **Epstein-Barr Virus (EBV)**
- Triade
 - Fièvre
 - lymphadénopathie au plusieurs territoires
 - la pharyngite



Mononucléose infectieuse

- confluence de l'enduit pultacé confèrent un aspect de fausses membranes, qui restent localisées aux amygdales ou peuvent s'étendre aux piliers



- Pétéchies impliquant la muqueuse buccale et palatine



Mononucléose infectieuse

- D'autres résultats cliniques
 - Splénomégalie - 50%
 - Hépatomégalie - 10%
 - Rash - 5%
- hyperlymphocytose à monocytes

Mononucléose infectieuse

- Le diagnostic sera confirmé par la mise en évidence d'IgM sériques:
- par le "MNI test".
- voire par la réaction de Paul-Bunnell (de plus grande sensibilité).
- enfin par le dosage d'anticorps de classe IgM si la réaction de Paul-Bunnell est négative.

Mononucléose infectieuse

- Prise en charge symptomatique
- Repos
- Eviter les sports de contact (-> splénique rupture?)
- Les glucocorticoïdes (cas graves)
- **L'amoxicilline - un risque important de rash cutané.**

Angines pseudomembraneuses

MNI

- Conditions socioéconomiques précaires
- une asthénie, fièvre puis angine
- Fausses membranes facilement décollables
- Respect de la luette

Diphtérie

- Patient en provenance d'une zone d'endémie(ex-URSS, Afrique du Nord) ou conditions de vie précaires.
- Fièvre modérée et AEG.
- Fausses membranes adhérentes, non dissociables
- Absence de traitement: syndrome toxique avec pâleur, adynamie, tachycardie, troubles du rythme cardiaque et de la conduction auriculo-ventriculaire

Angines ulcéreuses

- En règle unilatérale, plus profonde et recouverte d'un enduit nécrotique.
- Doit évoquer une angine de Vincent si l'atteinte est unilatérale.
- Il faut penser à une agranulocytose ou une hémopathie(Leucémie aigue) si l'atteinte est bilatérale

Angine de Vincent

- Due à une infection à des germes anaérobies
l'association fusospirillaire (le bacille fusiforme de Plaut-Vincent + les spirilles *Borrelia buccalis*)
- Angine latérale très douloureuse
- Sujet dont l'hygiène dentaire est mauvaise
- pénicillinothérapie par voie parentérale et traitement des causes bucco-dentaires pour éviter la récurrence.

Angine de Vincent

Lésion unilatérale



Angines pseudomembraneuses/ ulcéreuses



A. Angine pseudomembraneuse
MNI



B. Angine de Vincent

Syphilis primaire

L'amygdale atteinte est indurée et indolore,
Ulcère simple sur le site de l'infection
L'adénopathie est plus ferme avec un gros ganglion central entouré de ganglions plus petits.

sérologie syphilitique
Résout en 3-8 semaines si non traitée



Syphilis secondaire

- **Dissémination systémique**
- **Lésion symétrique cutanéomuqueuse**
- **éruption maculopapuleuse généralisée**
- **1/3 de développer condylomatose**



Angines vésiculeuses

- Exulcération du revêtement épithélial
- Éruption vésiculeuse fugace au niveau des amygdale
- 2 formes:
 - Angine herpétique : HSV 1 (Aulte)
 - Herpangine: Coxackie (Enfant)

Angines vésiculeuses

- Angine herpétique



Diagnostic différentiel des angines

- cancer de l'amygdale
- manifestation buccopharyngée d'une hémopathie
- zona pharyngien
- Aphthose
- éruptions bulleuses: affections rares (pemphigus, maladie de Duhring-Broq ...)
- infarctus du myocarde : violente douleur amygdalienne unilatérale.

V. Complications des angines

1. COMPLICATIONS LOCALES ET LOCORÉGIONALES

2. COMPLICATIONS GÉNÉRALES

1. Complications locales et locorégionales

- **Phlegmon péri-amygdalien**

Cellulite développée entre la capsule de l'amygdale et la paroi pharyngée.

Résultat de l'évolution depuis plusieurs jours d'une angine SGA ou inaugural (10%).

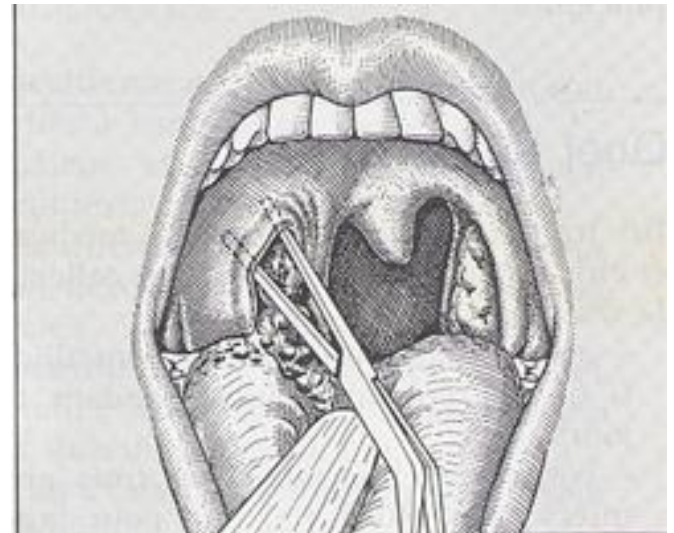
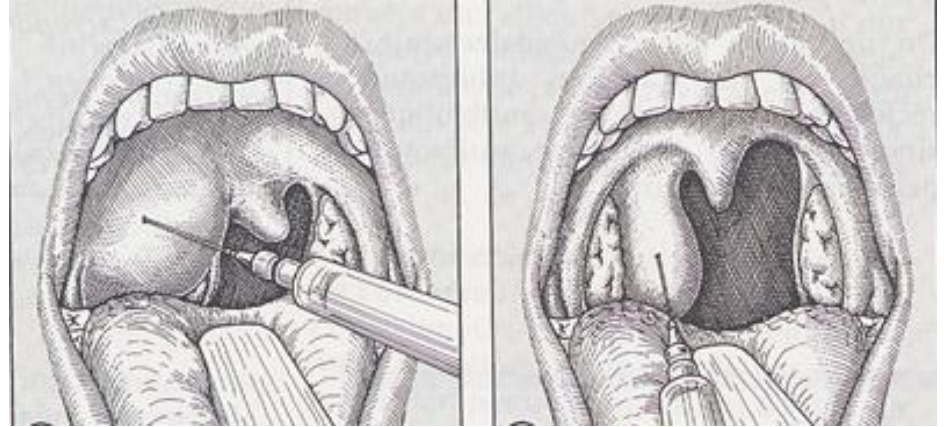
Phlegmon périamygdalien

- douleur pharyngée unilatérale
- la dysphagie intenses
- otalgie réflexe
- modification de la voix (sourde et étouffée)
- l'hyperthermie (38°C à 39°C)
- le trismus gêne l'examen
- bombement de la partie supérieure du pilier antérieur et du voile avoisinant
- la luette œdématisée est refoulée du côté opposé,
- l'amygdale est repoussée en bas, en arrière, en dedans



Phlegmon périamygdalien

- La ponction au stade suppuratif:
 - confirme le diagnostic
 - 1^{er} temps du traitement
 - Associe une Abth i.v puis relais per os total= 10J



Récidive fréquente
Indication d'une amygdalectomie

Adénite cervicale suppurative

Adénophlegmon cervical

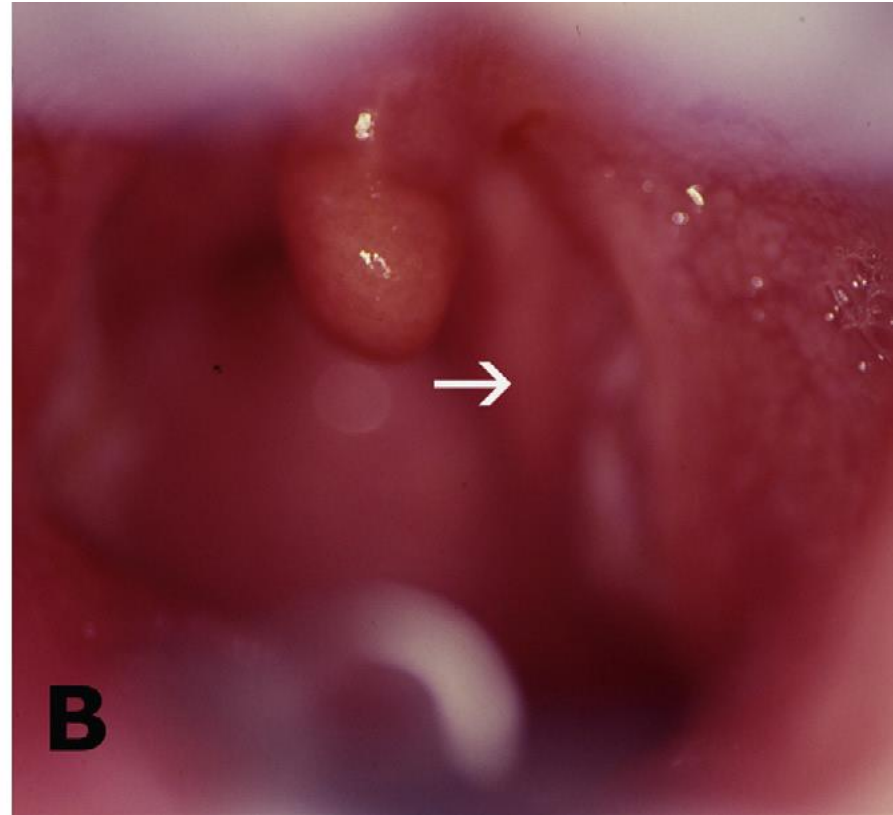
- Suppuration d'un ganglion lymphatique de la chaîne jugulocarotidienne.
- Complication plus rare.
- **torticolis douloureux.**
- empâtement cervical



Infections péripharyngées

- Infections rétropharyngées et rétrostyliennes
- Infections préstyliennes

Phlegmon de l'espace rétrostylien gauche



- A. Torticolis peu douloureux avec inclinaison latérale du cou, rotation de la tête et regard positionné vers le haut.
- B. Bombement de la collection en arrière de la loge amygdalienne gauche (flèche).

2. Complications générales

A. Glomérulonéphrites aiguës

B. Rhumatisme articulaire aigu et syndromes poststreptococciques

Indication de l'amygdalectomie

- épisodes aigus répétés et sévères (4/année)
et après un épisode de phlegmon.